

소화기계

소화성궤양·위염·위암 등 상부위장관 질환부터 간·담·췌 질환, 염증성 장질환과 대장암, 충수염·복막염·식도정맥류 등 응급 상황까지 다루는 계통이다.

이 계통의 질환·주제

- 소화성궤양 (위궤양 vs 십이지장궤양·천공)
- 소화성궤양 치료제
- 위염
- 덤핑증후군
- 외과적 수술 후 식이 교육
- 위암
- Child-Pugh score
- ICG test
- 간염 (A·B·C형)
- 간경화·간암
- 급성 담낭염
- 췌장염
- 췌장암
- 크론병 vs 궤양성 대장염 (IBD)
- 대장암·결장암
- 복막염
- 급성 충수염
- 복강내출혈
- 식도정맥류
- 그 외 (게실염·바렛식도·서혜부탈장·변비유발약 물·장폐색)

1 소화성궤양 Peptic Ulcer

정의·특징

위 또는 십이지장 점막에 발생하는 궤양으로, 발생 부위에 따라 통증 양상과 위험요인이 다르다.

비교

위궤양 vs 십이지장궤양

항목	위궤양	십이지장궤양
호발 연령	고령에 흔함	15~40세 젊은 나이에 잘 발병
주 원인	점막 방어요소 약화	위산 과다분비 등 공격요소 증가
위산도	정상~낮음	높음
가족력	비교적 적음	있음
통증 시기	식사 직후 통증, 음식물이 통증을 경감시키지 못함	공복 시 명치 통증, 한밤중 통증, 식후 2~3시간 후 발생
통증 완화	음식물로 잘 완화 안 됨	음식물·제산제로 쉽게 완화
출혈 양상	토혈이 흔함, 구토·토혈 흔함	흑색변(melena)이 많음, 혈변 증상 흔함
암 진행 가능성	상대적으로 높음	희박함
빈도	—	위궤양보다 더 흔하게 발생

합병증·천공

- 소화성궤양 천공 시: 갑작스럽고 날카로운, 참을 수 없이 심한 통증이 명치 중간부위에서 시작해 복부 전체로 퍼진다.
- 복부가 단단한 판자처럼(board-like rigidity) 된다. 오심·구토가 동반될 수 있다.
- 저혈압과 빈맥은 저혈량성 쇼크로 진행되면 나타난다.

주의/금기 · 천공은 외과적 응급상황이다. 판자 같은 복부 강직 + 명치에서 시작해 전복부로 퍼지는 극심한 통증은 천공을 의심한다.

시험 포인트 · 십이지장궤양 = 젊은 나이·위산과다·공복/야간통·제산제로 완화·흑색변. 위궤양 = 식후 통증·토혈·암 진행 가능성.

2 소화성궤양 치료제 Antacid / H2RA / PPI

제산제 (Antacids) 분비된 위산을 중화시켜 속쓰림 증상을 완화하나, 위산 분비 자체를 감소시키지는 않는다. 효과 지속 약 30~60분.

H2 차단제 (H2 blocker)

- 위산 생성 경로 중 히스타민에 의한 H2 receptor 자극 경로를 차단하여 부분적으로 위산 생성을 감소시킨다(완전 억제는 아님). 효과 지속 약 12시간. Ranitidine, famotidine 등.
- cimetidine**: cytochrome P-450을 억제하는 유일한 H2RA로 많은 약물의 대사를 지연시킨다. Phenytoin, theophylline과 상호작용 가능성이 크다.
- ranitidine**: 궤양 치유에 약 4~8주 소요, 더 장기 치료가 필요할 수 있다. 유해반응이 드물고 BBB를 통과하지 않아 중추신경계 억제 효과가 나타나지 않는다. 제산제는 흡수를 방해하므로 함께 복용하지 않는다.

PPI (Proton Pump Inhibitor)

- 위산 분비 마지막 경로인 proton pump를 완전히 차단해 위산 분비 자체를 억제한다. H⁺/K⁺-ATPase를 억제해 산 분비를 줄인다. 효과 지속 약 72시간. Lansoprazole, omeprazole 등.
- omeprazole**: 소화성궤양·위식도역류 단기치료에 4~8주 사용. 장기간 사용 시 위암 발병 증가와 관련이 있어 2개월로 제한되는 경우가 많다.

기타

- 합성 프로스타글란딘 유도제 **misoprostol**.
- COX-1은 적절한 신장 관류와 위점막층 보호·유지를 포함한 여러 기전을 통해 장기 건강에 영향을 미친다.
- CCB(예: amlodipine) 사용 시 위괄약근 압력이 낮아져 GERD가 악화될 수 있다.

주의/금기 · PPI 장기 사용 시 철분·vit B12·Ca·Mg 흡수 감소로 골절 위험이 높아지고, 폐렴·C. difficile colitis 발생 위험도 증가한다.

3 위염 Gastritis

급성 위염 산성 위액 또는 보호 점막층을 손상시키는 물질에 위점막이 노출될 때 손상이 유발된다. 대표 물질은 NSAIDs로, 프로스타글란딘 합성을 저해해 위 보호 점막 생성·점액 분비를 방해함으로써 위점막이 노출되는 환경을 만든다.

- 만성 위염**
- 급성 위염이 반복되면 점막이 위축되고 상피 화생을 초래하는 점막의 만성 염증이 유발된다.
 - **자가면역성(위 기저부) 위염**: 위산을 분비하는 위 기저부 벽세포에 대한 자가항체가 생성되어 벽세포를 파괴, 위 기저부 위축과 염산 분비 이상을 초래한다. 또한 내인성 인자 분비 저하로 vit B12 결핍성 빈혈인 **악성 빈혈**을 유발한다.
 - **헬리코박터 감염성 위염**: 만성 위염의 90%가 헬리코박터균 만성 감염에 의한다. 균은 강력한 요소분해효소를 분비, 암모니아를 생성해 위산을 중화시키며 생존 환경을 만든다. 위 상피세포 점막층 감염이 만성으로 진행되면 만성 위염이 발생한다.

- GERD 진단 참고**
- GERD는 특별한 진단검사 없이 속쓰림과 산 역류의 특징적 증상으로 진단한다.
 - GERD 환자에게 H. pylori를 찾기 위한 분변검사는 추천되지 않는다.
 - 상부 위내시경은 GERD 진단의 필수 조건이 아니며, 보통 GERD 합병증이 의심될 때 시행한다.

4 덤핑증후군 Dumping Syndrome

정의 위 절제술 후 위 배출이 촉진되면서 생기는 증상이다. **고삼투성 식사**를 할 때 나타난다.

증상 어지러움, weakness, diaphoresis(발한), epigastric fullness, tachycardia, abdominal cramping 등. 초기 증상은 보통 **식후 5~30분**(또는 식사가 끝날 즈음)에 발생하며 현기증·빈맥·실신·발한·창백·심계항진·눅고 싶은 열망 등이 나타난다.

- 간호중재·교육**
- 소량씩 자주 식사한다.
 - 수분 섭취를 제한한다.
 - **저탄수화물 식사**를 한다.
 - 식사 후 **축위(누운 자세)**를 취한다.

5 외과적 수술 후 식이 교육 Post-op Diet Education

교육 내용

- 수술 후 합병증으로 발생할 수 있는 덤핑증후군, 식후 저혈당, 담즙역류성 위염 등에 대해 교육한다.
- **덤핑증후군 예방:** 소량씩 자주 식사, 수분 섭취 제한으로 저탄수화물 식사. 식후 15~30분(또는 식사 끝날 즈음) 증상이 나타날 수 있으므로 식후 측위 자세를 취한다.
- **식후 저혈당:** 농축된 탄수화물 덩어리가 십이지장으로 빨리 넘어가면서 인슐린 분비를 촉진시켜 저혈당이 발생한다. 소량씩 자주 식사하고 수분 섭취를 제한한다.
- 커피·차·콜라·알코올 등을 섭취하지 않도록 하고, 흡연자에게는 금연하도록 한다.

6 위암 Gastric Cancer

증상

체중 감소, 식욕 부진, 삼키기 어려움, 복통, 배변습관 변화, 혈변 등. 이런 증상이 있으면 반드시 병원을 방문해 검진받도록 한다. 서구 생활습관의 영향으로 젊은 환자에서도 발병률이 높아지고 있다.

수술 후 식이 교육

- 수술 후 소화·흡수율이 줄고 식사량이 저하되어 체중 감소·영양 불균형이 초래될 수 있다.
- 양질의 단백질 식품 등 여러 영양소를 골고루 섭취한다.
- 음식은 조금씩 자주 천천히 먹고, **식사 중 수분 섭취를 자제** 한다.
- 맵고 짠 음식은 피하고, 고기·과일·채소 등은 되도록 부드러운 상태로 섭취한다.
- 퇴원 후에도 식사 적응을 위한 주기적인 교육이 필요하다.

7 Child-Pugh score Child-Pugh classification

정의·용도

원래 간경변 환자에서 수술 위험 및 수술 후 생존률을 평가하는 데 사용되었고, 현재는 수술 후 경과, 간이식 적합 판정, 약물 용량 조절 등에도 사용된다.

5가지 지표

- 혈청 빌리루빈(높을수록 높은 점수), 혈청 알부민(낮을수록 높은 점수), 복수, 신경학적 이상, 프로트롬빈 시간 연장.
- 복수: 없음 1점 / 이뇨제로 쉽게 조절 2점 / 조절 안 됨 3점.
- 신경학적 이상: 없음 1점 / 의학적 조치로 쉽게 처치 가능한 경미한 증상 2점 / 조절되지 않는 혼수 3점.

분류·생존률

Child-Pugh 분류 및 1년 생존률

총점	Class	1년 생존률
5~6점	A	100%
7~9점	B	81%
10~15점	C	45%

8 ICG test Indocyanine Green

원리

ICG는 90% 이상이 간세포에서 섭취되어 간으로만 배설되는 특징이 있어, 투여 후 정체율이 간 기능 지표로 사용된다. 투여 15분 후 혈장에 남은 양을 측정하는 **ICG R15**(retention 15) 검사가 많이 이용된다.

해석

검사값이 높을수록 ICG가 제거되지 않고 남아있는 것이므로 간기능 저하를 시사한다. 10% 이하가 정상치이며, 40% 이상이면 예후가 매우 불량하다.

A형 간염 (HAV)

- HAV 감염이 원인이며 오염된 음식·물을 통해 전염(경구 감염). 피막이 없는 RNA 바이러스.
- 치료약은 없고 대증요법이 주 치료, 고단백 식이요법과 간의 휴식이 도움. 예방은 개인위생 준수 및 고위험군 예방접종.
- 백신 대상: 12~23개월 모든 영유아, 백신 미접종 2~18세 유아·청소년, A형간염 보균자와 직접 접촉한 자, 면역을 얻고자 하는 모든 사람.
- 만성화되지 않으며, 어린이는 거의 무증상이고 연령이 높아질수록 증상이 심해진다. 20세 이상 성인은 무증상으로 이미 면역이 형성된 경우가 많다.
- **증상:** 오심, 식욕부진, 열, 권태감, 복통, 황달.

B형 간염 (HBV)

- HBV 감염이 원인이며 혈액 등 체액으로 감염. 만성 간질환의 가장 흔한 원인 중 하나.
- 성인은 대부분 특별한 치료 없이도 저절로 회복(충분한 휴식·고단백 식이). 필요시 항바이러스제, 심각한 경우 간이식.
- **감염 경로:** 수직감염(보유 산모 → 신생아), 수평감염(혈액·정액·타액의 바이러스가 주사바늘·성접촉·상처 점막/피부로 감염).
- 잠복기 45~180일을 거쳐 전신 권태, 식욕부진, 짙어진 소변, 황달, HBV 항원 출현, AST/ALT 상승. 무증상인 경우도 있다.
- 모든 국민은 백신을 접종해야 하고, B형 간염 산모의 신생아는 출생 시 **B형 간염 백신 + 면역글로불린**을 투여한다.
- B형 간염 항원 양성이라면 노출 후 3~4주가 되어야 하며, **IgM 양성**은 급성 B형 간염을 의미한다.

C형 간염 (HCV)

- HCV 감염이 원인이며 혈액 등 체액으로 감염. 치료는 대부분 경구 항바이러스제(interferon 사용 가능). **백신이 없다.**
- 혈중 바이러스 농도가 낮고 숙주 면역체계를 빠져나가 특이적 항체가 잘 생성되지 않으며 유전적 변이가 심해 백신 개발이 어렵다.
- 감염자의 70~80%가 만성화되고, 만성 감염자의 20% 이상이 간경변·간암으로 진행한다(C형 간염 환자의 50~80%가 만성 간염으로 진행). 만성 간염·간경변증·간암의 중요한 원인.
- 예방: 1회용 주사기 사용, 침·문신·피어싱 시 소독된 도구 사용.
- **HCV 항체**는 일반적으로 노출 후 2~6개월 사이 발생. 노출된 지 6개월이 안 된 경우 **HCV RNA 검사**로 확진하며, **HCV RNA 음성**이면 HCV 감염이 아니다.

바이러스성 간염 공통

흔한 임상 특징은 오심·식욕부진·발열·권태감·복부통증·황달이며, 점토색 변·어두운 색 소변·관절통이 유발된다. 진단검사에서 AST가 정상 **20배 이상** 높게 나타난다.

병태생리

간세포 손상(간염)이 장기간 지속되며 간섬유화증이 진행되고, 간 전반에 진행되면 간경변증이 된다. 섬유화로 간 혈류 유입이 잘 안 되어 간문맥압이 증가하고, 문맥고혈압 합병증으로 **복수·정맥류**가 발생한다. 정상 간세포가 적어지면서 단백질 합성·해독 장애로 황달·간성뇌증이 발생하고 간암으로 이어질 수 있다.

원인

만성 B형 간염 약 70%, 알코올성 간염, 만성 C형 간염 순으로 많다. 그 외 지방간염, 경화성 담관염, 유전적 간경변 등.

증상

- 초기에는 대개 무증상, 진행 후 식욕부진·소화불량·복부 불쾌감 등 비특이적 증상.
- 복수가 차면 복부팽만감·하지 부종·숨참. 식도·위 정맥류 출혈, 말기에는 간성뇌증.
- 거미상 혈관종(앞가슴의 거미줄 모양 모세혈관 확장), 수장 홍반(손바닥이 붉어짐).
- 남성은 유방 비대·고환 위축, 여성은 월경 불규칙.

진단

임상검사(간효소 상승, 응고검사 이상, 알부민 감소, 빈혈, 혈소판 감소증, 빌리루빈 상승, BUN/Cr 상승), 복수천자, 초음파(복수 발견·간/담관 해부학적 이상 감별), CT(간경화·문맥고혈압 관찰). 복수가 있을 때 타진 시 **이동탁음(shifting dullness)**·액체파동(fluid wave)을 확인한다.

치료

- 무엇보다 **원인 제거가 필수**(알코올성은 금주·균형식, 바이러스성은 항바이러스 치료 선행). 초기 적절한 치료 시 대부분 정상 생활 가능, 금주가 매우 중요.
- **락툴로오스(lactulose) 관장**: 삼투성 설사를 유발하고 장내를 산성화해 암모니아를 변으로 제거. 1일 2~3회 대변을 보도록 조절하여 의식 회복 및 혈중 암모니아 수치 저하를 유도(간기능 저하 시 암모니아가 배출되어 독성 발생).
- **간암 치료**: TNM 병기·Child-Pugh score·전신 상태를 종합하여 수술/간이식, 고주파열치료술, 경동맥화학색전술(TACE), 방사선치료, 항암치료 등 시행. 항암제는 LENVIMA(lenvatinib)를 1차로 사용하기도 한다.

간성뇌증·간부전

- 피부·결막 황달의 가장 큰 원인은 간부전(체내 빌리루빈 제거능력 저하).
- 필적 약화는 간질환의 초기 징후이고, 정신착란·혼란·졸림의 미묘한 변화는 간성뇌증의 후기 증상이다.
- **자세고정불능(asterixis) 사정**: 대상자의 팔을 곧게 펴고 손바닥을 아래로, 손목을 구부리고 손가락을 편 상태를 유지하게 요청한다. 손과 팔을 곧게 폈을 때 손가락·손목이 불규칙하게 파닥거리는 움직임으로, 간성뇌병증에서 흔히 발견된다.

시험 포인트 · 간성뇌증 = asterixis(자세고정불능) + 혈중 암모니아 상승 → lactulose로 암모니아 배출. 간경변 복수 → shifting dullness.

11 급성 담낭염 Acute Cholecystitis

증상

- 우상복부 통증(담도 산통으로 갑작스런 통증, 왼쪽 견갑골로 방사 가능), 압통 (Murphy's sign).
- 대부분 오심 호소, 구토(종종 일시적으로 완화), 열(안 날 수도 있음), 움직일 때 통증 악화.
- 20~50%에서 황달, 담낭이 만져지는 경우는 거의 없음. 고령 환자는 Murphy sign 이 나타나지 않아 진단이 지연될 수 있다. 무증상은 보통 담석증이다.
- 지방식·알코올·카페인 섭취 후 시간이 흐르면서 생성된다.

진단

검사 결과 백혈구(WBC)와 간효소(hepatic enzyme) 증가.

위험요인

50세 이상, 여성, 비만, 고지혈증, 갑작스러운 체중감소, 임신 등.

합병증 · 흔한 중증 합병증은 췌장염과 패혈증이다.

12 췌장염 Pancreatitis

병태생리

췌장 효소(주로 트립신)에 의해 췌장 분비샘이 파괴되거나 염증이 발생하며 발병한다. 췌장 내에서 췌장 효소가 활성화되면 **자가소화(autodigestion)**로 염증과 괴사가 초래된다. 급성에서는 부분적 괴사가 발생 가능하고, 합병증으로 다발성 농양이 발생할 수 있다.

원인

주 원인은 **담석과 알코올**. 약물·바이러스에 의해서도 발생.

증상

- 상복부 중앙의 급성 천자통으로 등·왼쪽 견갑골·옆구리로 방사. 심한 오한·구토 유발.
- 특이 증상: 배꼽 주위 청색 착색 **Cullen sign**, 옆구리에 멍이 생기는 **Grey Turner sign**.
- 복통·오심·구토·설사·빈맥 등 동반.

진단

혈액검사상 **lipase, amylase 상승**, WBC·CRP 등 염증 수치 상승. ERCP 같은 영상검사.

치료

- 통증 치료, 적극적 수액 요법과 함께 **금식**. 이차 감염 예방·치료 위해 항생제 사용, 수술적 치료 고려.
- 저혈압을 보일 때 가장 우선 중재는 **저혈압 교정**이며, 췌장 효소 공급은 급성기 이후에 필요하다.

만성 췌장염

장기화되면 만성으로 진행. 췌장 기능 부전·지방변·영양 불균형·체중 감소 동반. 치료는 금연·금주 등 생활습관 교정, 통증 조절, 저지방 식이요법 등 대증치료, 췌관 스텐트 삽입(협착·폐쇄 완화), 췌석에 의한 폐쇄 시 체외충격파쇄석술로 췌석제거술, 복강 신경총 신경 차단술, 췌장 절제술 등.

비교

급성 췌장염 vs 만성 췌장염

항목	급성 췌장염	만성 췌장염
발생	갑자기 발생	몇 년에 걸쳐 진행
주요 원인	음주, 담석 등	여러 원인에 의한 자극
통증	심한 복통	경미했던 복통이 장기간 심해졌다 나아졌다 반복
경과	적기에 치료하면 쉽게 회복 가능, 치료가 늦으면 췌장 기능 이상	췌장 기능 손실로 다른 문제 발생 가능

13 췌장암 Pancreatic Cancer

위험요인 가족력, 흡연, 음주, 당뇨, 만성 췌장염 병력, 비만 등.

증상

- 복통, 종양으로 담즙이 제대로 흐르지 못해 황달, 소화액 통로가 막혀 소화장애·체중 감소·지방변·식욕부진·구역감.
- 갑작스레 시작되는 통증으로, 대개 걷거나 똑바로 누울 때 심해지고 앉거나 앞으로 기울이면 완화된다.

진단 CT, 내시경 초음파, ERCP 등 영상검사. 조기 발견이 어렵고 조기 발견 가능한 혈액검사는 없다. 발생 시 **CA19-9** 혹은 **CEA** 종양표지자가 검출될 수 있다. 황달로 빌리루빈 증가, 2차적 췌장염으로 amylase 상승.

치료

- 수술적 절제와 항암화학요법. 수술은 **Whipple operation** (담낭·담관·췌장 대부분·십이지장 일부·위 일부·비장 및 근처 림프절 제거).
- 췌장 절제 시 췌장의 꼬리는 소화효소·호르몬 생성 기능이 있어 보존한다.
- 항암화학요법: Gemcitabine, 5-FU 등.

14 크론병 vs 궤양성 대장염 IBD: Crohn's vs Ulcerative Colitis

정의 둘 다 염증성장질환(IBD)으로, 장관 내 비정상적 만성 염증이 호전과 재발을 반복하는 질환이다. 정확한 기전은 불분명하며 환경적·유전적·면역학적 요인이 복합 작용한다.

비교

궤양성 대장염 vs 크론병

항목	궤양성 대장염	크론병
침범 깊이	mucosa~submucosa(점막~점막하층)	transmural(장벽 전층)
침범 부위	항상 직장(rectum)부터 침범, 근위부로 진행하여 회장 말단까지 가능. 결장 점막에 국한	입(oral)부터 항문(anus)까지 전 GI tract 가능, 회장·결장이 가장 흔함
침범 양상	연속적, 광범위한 표재성 궤양, 장의 모양 유지	불연속적 반점 형태(skip lesion), 깊고 날카로운 선상 열상·궤양, 근육층 비후로 내강 협착
특징 증상	복통·복부경련·변실금·열·피로, 특징적으로 혈성 설사(bloody diarrhea)·직장 출혈	복통·복부경련·설사·오심·구토
육아종	비육아종 병변	비건락성 육아종 병변
합병증	장관폐색·탈수·흡수 불량·철 결핍성 빈혈·악성 종양·원발성 경화성 담관염	탈수·협착·농양·누공·엽산/Ca/vit D 흡수 장애
수술	심한 경우·악성 종양 시 치료적 목적으로 수술	합병증 치료 제외하고는 수술이 금기

치료

(CRAMPS)

- Control diarrhea and infection
- Relieve pain and restore fluid
- Anticholinergics and antimicrobials
- Meals — correct nutritional deficiencies

- Psychological counseling
- Support emotionally

식이·영양 교육 소량씩 자주 식사, 저지방식이·저섬유식이·저잔사식이, 자극이 적은 음식으로 섭취. 장을 통한 비타민 흡수가 방해되므로 **vit B12·vit D**를 보충한다.

주의/금기 · 크론병은 합병증 치료를 제외하고는 수술이 금기다.

15 대장암·결장암 Colorectal Cancer

정의 대장·직장에서 발생하는 암으로 대다수가 선종성 용종이라는 양성 종양에서 시작한다. 보통 용종이 1cm 이상이고 2개 이상이며 dysplasia 소견 시 암일 가능성이 높아진다.

위험인자 50세 이상, 비만, 2형 당뇨, 가족력, 염증성 장질환(궤양성 대장염·크론병), 방사선치료 이력, 식습관, 흡연, 용종증 가족력 등.

증상 (위치별)

- 초기에는 증상이 없을 수 있다.
- **우측 대장암**: 설사·소화불량·복부팽만·복통·체중 및 근력 감소.
- **좌측 대장암**: 변비·혈변·점액변·장폐색.
- **직장암**: 변비/설사·혈변·배변 후 잔변감·배변 시 통증.
- **결장암**: 잠혈검사 양성, DRE 시 짙은 갈색의 변, 빈혈 증상 시 대장내시경이 필요하다.

진단·검진 대장내시경과 colon biopsy 선행, 혈액검사상 **CEA와 CA19-9** 종양표지자 검출. 50세 이상 남녀는 대장내시경 검진을 주기적으로 받으며, 국내 보건복지부는 5년마다 검진을 권고한다.

치료 수술요법·방사선요법·항암화학요법·표적치료요법.

대장절제술 후 식이 교육

- 장 길이에 따라 영양 흡수 능력이 달라지므로 주의가 필요하다.
- 변의 굳기 정상화를 위해 충분한 수분을 섭취한다.
- 소장 절제 부위가 많으면 소화·흡수가 불량하고 설사가 쉬우므로 **설사 유발 음식을 피하고** 점차적으로 섬유소 섭취를 늘려간다.

16 복막염 Peritonitis

증상 복통, 약한 장음, 복부 강직, 손을 땔 때 통증(반동압통).

주의 · 복막염을 의심할 때는 수술을 준비해야 한다.

17 급성 충수염 Acute Appendicitis

특징

- 10~30세에 가장 많이 발생. 고령에서는 잘 발생하지 않아 진단이 지연될 수 있다.
- 충수의 해부학적 위치에 따라 증상이 다를 수 있음을 고려한다.

사정·징후 복부 측진에서 반동압통 양성 → Blumberg's sign. 우하복부 반동압통으로 McBurney's point 압통. 복막 염증 부위에서 칼로 찌르는 듯한 통증.

진단 급성 충수염·충수파열 의심 시 시행하는 검사는 복부 CT로, 충수의 해부학적 이상 확인에 다른 영상검사보다 월등하다.

18 복강내출혈 Intra-abdominal Hemorrhage

징후

- **Grey Turner 징후**: 옆구리 부위의 푸르거나 붉은색 변화로 복강내 출혈을 의미(푸르스름한 착색).
- **Cullen 징후**: 배꼽 주변 피하조직의 멍과 부종. 급성 췌장염을 시사하며, 그 외 외상·대동맥파열·자궁외임신에서도 보일 수 있다.
- 복부 경직은 복부 대량 출혈을 의심하는 중요 사정 소견이다.

주의 · 복강내출혈 의심 환자에게 급속 수액요법을 수행했음에도 저혈압이 지속되면 수술을 먼저 준비해야 한다.

19 식도정맥류 Esophageal Varices

정의·의심 과도한 알코올 남용으로 유발 가능하며, 식도 조직이 약해져 가벼운 외상으로도 출혈할 수 있다. 알코올 남용 과거력이 있는 환자의 비위관에서 검붉은색 혈액이 지속적으로 나온다면 식도정맥류를 의심한다.

치료 TIPS(transjugular intrahepatic portosystemic shunt, 경정맥 간내 문맥전신 단락술): 간내에서 간정맥과 간문맥을 연결하는 통로를 만든 후 넓히고 스텐트를 삽입해 단락을 형성하는 치료법이다.

주의 · TIPS는 스텐트가 막히거나 간성 혼수가 초래되는 부작용이 발생할 수 있다.

20 그 외 기타 Others

게실염 급성 대장게실염이 의심될 때 **조영증강 CT**로 장벽이 두꺼워지는 상태를 확인하는 데 도움이 된다.

바렛식도 바렛 식도는 **식도선암의 위험인자**로, 상부 위내시경과 생검으로 평가한다.

서혜부 탈장 서혜부 탈장이 의심되는 환자를 검진할 때는 선 자세로 검진하는 동안 배 아래 힘을 주고 기침하도록 한다.

변비 초래 약물

- amlodipine (CCB로 장운동 저하)
- oxybutynin (항콜린 성질로 장에서 점액 건조)
- naproxen (NSAIDs, 프로스타글란딘 억제로 변비 유발)
- prevacid/lansoprazole (PPI, 변비와 관련)
- 칼슘보충제도 변비와 관련 있음

장폐색 일반적으로 소장폐색에서 혈관 내 → 혈관 밖으로의 액체 이동이 심하다. 따라서 장폐색 환자의 급성기 간호에서 **저혈량증**을 주의해야 한다.

본 노트는 PDF를 300dpi로 렌더링 후 한국어 OCR(EasyOCR)로 추출한 텍스트를 의학용어 기준으로 교정·재구성한 자료입니다. OCR 특성상 일부 수차·표기에 오차가 있을 수 있으니 원문과 교차 확인하세요. 페이지 스캔 이미지는 각 항목의 [원문] 링크/그림에서 확인할 수 있습니다.